

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine 3 Constantine – SALAH BOUBNIDER
Service d'Hématologie – CHU Constantine

Raisonnement clinico-biologique

Responsable de stage de simulation : Dr Kebaili Sihem

Formateur : Dr Kebaili Sihem

Module : Onco-Hématologie

Niveau : 4e année Médecine

FICHE MÉMO ECOS
Anémie ferriprive par malabsorption

Cette fiche est destinée aux étudiants comme aide-mémoire pour préparer une station ECOS sur l'anémie ferriprive microcytaire chez la femme jeune, avec échec du fer per os et suspicion de malabsorption.

1. Points clés à ne pas oublier

- Rechercher systématiquement le syndrome anémique : fatigue, dyspnée d'effort, palpitations, céphalées, troubles de la concentration.
- Rechercher les signes de sidéropénie : chute de cheveux, ongles cassants, pâleur, éventuellement pica.
- Toujours lire la NFS en détail : Hb, VGM, TCMH, CCMH, plaquettes, leucocytes.
- Demander ou interpréter le bilan martial complet : ferritine, fer sérique, transferrine/CTF, coefficient de saturation.
- Penser aux traitements déjà reçus (fer per os) et à leur efficacité.

2. Démarche de raisonnement (schéma simple)

- 1) Clinique : syndrome anémique + signes de sidéropénie.
- 2) NFS : anémie microcytaire hypochrome.
- 3) Réticulocytes : arégénérative (faibles).
- 4) Bilan martial : ferritine basse + fer sérique bas + CTF élevée + saturation très basse → anémie ferriprive.
- 5) Contexte : règles, alimentation, troubles digestifs, traitements antérieurs.
- 6) Ici : échec du fer per os + troubles digestifs → suspecter malabsorption (ex. maladie cœliaque).

3. Structure de réponse en 5 blocs (5 minutes)

- Bloc 1 – Diagnostic (≈ 30 secondes) : annoncer clairement : « Il s’agit d’une anémie ferriprive microcytaire hypochrome, probablement liée à un problème d’absorption digestive. »
- Bloc 2 – Arguments biologiques (≈ 1 minute) : citer les éléments de NFS, réticulocytes et bilan martial qui prouvent la carence en fer.
- Bloc 3 – Étiologie (≈ 1 minute) : expliquer pourquoi vous suspectez une malabsorption (troubles digestifs, échec du fer oral) et mentionner brièvement les explorations à prévoir.
- Bloc 4 – Conduite thérapeutique (≈ 1 minute) : justifier la non-indication systématique de transfusion et proposer le fer injectable IV comme traitement adapté dans ce contexte.
- Bloc 5 – Explication à la patiente (≈ 1 min 30) : reformuler en langage simple le diagnostic, le lien avec les symptômes (fatigue, chute de cheveux, ongles) et le plan de prise en charge.

4. Grille ECOS simplifiée (/20)

Item	Critères	Points
Communication	Accueil, écoute, empathie, mots simples	/4
Diagnostic	Anémie ferriprive microcytaire correctement nommée	/4
Raisonnement	Lien bilan martial + malabsorption / échec fer per os	/4
Prise en charge	Explication transfusion vs fer IV, plan clair	/4
Organisation	Réponse structurée, hiérarchisée, dans le temps	/4

5. Phrases utiles à placer

- « Votre fatigue, la chute de cheveux et les ongles cassants sont liés à un manque de fer. »
- « Vos analyses montrent une vraie carence en fer, pas seulement une anémie. »
- « La transfusion est réservée aux situations graves ou mal tolérées, ce n’est pas le traitement habituel de cette forme d’anémie chronique. »

- « Comme les comprimés n'ont pas fonctionné et que votre intestin absorbe mal le fer, nous allons utiliser du fer injectable. »
- « Nous allons aussi rechercher la cause de cette malabsorption, notamment au niveau digestif. »